Colecistectomia Videolaparoscópica

5 TEMPOS CIRÚRGICOS · 4 ESTRUTURAS-TABU

SEQUÊNCIA OPERATÓRIA

1 ACESSO E POSICIONAMENTO

Decúbito dorsal, Trend. reverso 30°
Pneumoperitônio CO2 12 mmHg
Trocartes em losango francês

2 EXPOSIÇÃO DO HILO

Fundo da vesícula → diafragma
Hartmann → tração lateral/inf.
Identificar lig. hepatoduodenal

3 DISSECÇÃO DE CALOT (CVS)

Janela hep-cístico aberta
Liberar terço inf. do leito
CVS: 2 estruturas → vesícula

■ **Sem CVS = NÃO clipar (considerar conversão)**

4 CLIPAGEM E SECÇÃO

Cístico: 2 clipes prox + 1 dist
A. cística: 2 clipes + secção
Colangiografia se indicada

■ **80% das lesões biliares = confusão anatômica**

5 DISSECÇÃO DO LEITO + SAÍDA

Vesícula com gancho/cautério
Hemostasia leito + lavagem
Retirada em saco pelo umbilical

CHECKLIST MENTAL ANTES DE FECHAR

- ■ CVS confirmado antes de clipar?
- ■ Cístico e a. cística clipados separadamente?
- ■ Leito sem sangramento?
- ■ Colangiografia indicada/realizada?
- ■ Vesícula em saco?
- ■ Indicação de dreno?
- ■ Cavidade seca?

PÓS-OP: dor desproporcional → suspeitar lesão

Bile na cavidade → reabordagem precoce

ESTRUTURAS-TABU

1 Via biliar principal

Hepatocolédoco
Lesão: classificação Strasberg
Considerar variação anatômica

2 Artéria hepática direita

Atrás do cístico em 80%
Lesão: necrose hepática
Cuidado com a. cística em alça

3 Veia porta

Lig. hepatoduodenal post.
Lesão: hemorragia maciça
Não dissecar profundamente

4 Duodeno / cólon transverso

Aderências em colecistite
Lesão térmica frequente

CRITICAL VIEW OF SAFETY

Triângulo hep-cístico LIMPO
Terço inf. do leito EXPOSTO
2 estruturas entrando na vesícula
"Sem CVS, sem clipe — converter ou colangiografar"

MNEMÔNICO P·T·C·D·L

P Posicionamento + pneumo
T Trocartes em losango
C Calot + CVS obrigatório
D Dissecção e clipagem
L Leito + lavagem + saída

"Posicionei, Triangulei, fiz o CVS de Calot,, Dissequei com cuidado, Lavei e saí."